Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Balcão Virtual (Audiências e Assessoria do Magistrado): (54) 97100022 Dr. Montaury, 2107 - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Balcão Virtual (CAP Cível): (54) 99679 0955 - Email: frcaxsul3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5011773-62.2023.8.21.0010/RS

AUTOR: JOAO VICTOR MECCA SOMACAL

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

JOÃO VICTOR MECCA SOMACAL ajuizou ação cominatória contra a **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA,** sustentando que é beneficiário da ré e portador de epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas, com crises parciais complexas. Faz tratamento específico há onze anos, conforme laudo da neuropediatra (Maria do Carmo Torres Mattana), já utilizou diversos fármacos, mas não obteve resultado. A médica prescreveu o tratamento com Trileptal (oxcarbazepina) e Vimpat (lacosamida) para controlar suas crises. Fez digressões sobre o alto custo dos medicamentos e sobre a negativa da ré no fornecimento, sob o argumento de que se tratam de medicamentos de uso domiciliar. Defendeu a aplicação do ECA e afirmou que o tratamento da sua doença não pode ser limitado pela demandada, invocando a conduta ilícita da operadora em negar o fornecimento dos medicamentos indicados. Em sede de tutela de urgência, requereu seja a ré compelida a fornecer de forma gratuita a medicação Trileptal 300mg (60cp ao mês) e Vimpat 150 mg (28cp ao mês), tudo conforme prescrição médica. Pediu a procedência da ação para tornar definitiva a liminar, impondo à ré a obrigação de fornecer os medicamentos indicados, na forma e quantidade prescrita pela médica credenciada, sem qualquer ônus. Juntou documentos e requereu a concessão da AJG.

O feito foi distribuído ao Juizado da Infância e Juventude - JIJ, sendo reconhecida a incompetência daquele juízo ao enfrentamento da causa (evento 3, DESPADEC1), com redistribuição a esta Vara e Juízo.

Na decisão do (evento 14, DESPADEC1) foi indeferido o pleito liminar.

A ré contestou invocando a ausência de interesse processual. No mérito, confirmou que o autor é beneficiário de plano que opera (coletivo empresaria), que em setembro de 2022 solicitou a medicação Vimpat, não sendo autorizado o fornecimento por ser de uso domiciliar. Em relação ao outro medicamento, o autor não fez pedido para fornecimento. A lei 9.656/98 prevê a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. O contrato prevê a mesma exclusão, assim como as normativas da ANS. Colacionou jurisprudência sobre o tema e afirmou inexistir obrigação no custeio dos medicamentos, tendo agido conforme o contrato. Pediu o acolhimento da preliminar ou a improcedência da demanda. Juntou documentos.

O autor manifestou-se sobre a resposta.

Na decisão do (evento 34, DESPADEC1) foi afastada a preliminar.

Os pedidos de prova oral e pericial foram indeferidos (evento 44, DESPADEC1).

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela improcedência da demanda.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Tratando-se de questão meramente de direito, passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Pretende o autor seja imposta à ré a obrigação de fornecer os fármacos Trileptal e Vimpat, na forma, quantidade e periodicidade prescritas pela médica assistente. Afirmou ser portador de epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal - parcial), com crises parciais complexas, sustentando a obrigatoriedade de fornecimento pelo plano.

O autor é beneficiário do plano de saúde operado pela ré (evento 1, OUT7) e demonstrou ser portador da patologia informada (evento 1, LAUDO4), recebendo prescrição médica para uso da medicação prescrita pela médica, cujo fornecimento (de um dos medicamentos solicitado) foi negado pela ré (evento 1, OUT3).

O cerne da controvérsia é saber da obrigatoriedade ou não de a operadora de saúde fornecer os medicamentos receitados ao autor para o tratamento da patologia que está acometido.

O julgado não deve desbordar daquilo que já foi decidido em sede liminar. Isso porque o contrato que regula a relação entre as partes (evento 28, ANEXO2 e evento 28, ANEXO10) faz referência específica aos eventos não cobertos pelo plano (clausula quinta, módulo 1), discorrendo sobre o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar:

DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS

CLÁUSULA QUINTA: Não são cobertos, neste módulo, os procedimentos que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, bem como os serviços de anestesia geral, recuperação pós-anestésica, UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, CETIN – Centros de Tratamento Intensivos, e similares.

Serviços de enfermagem e medicamentos para tratamento domiciliar.

Como se pode depreender das bulas dos medicamentos, ambos são de uso oral, sem qualquer indicativo de que a medicação deva ser ministrada em ambiente hospitalar.

O medicamento Trileptal[1] é usado para tratar crises parciais (convulsões simples, complexas e secundariamente generalizadas) e generalizadas tônico-clônicas, cuja administração é via oral.

Já o medicamento Vimpat[2] é utilizado no tratamento de convulsões de início parcial em pacientes com epilepsia a partir de 16 anos de idade , bem como na terapia adjuvante (em conjunto com outro medicamento antiepiléptico) no tratamento de crises parciais com ou sem generalização secundária em pacientes a partir de 16 anos de idade com epilepsia e também deverá ser ingerido.

A própria lei 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar das exigências e coberturas mínimas que o plano de saúde deve garantir aos seus segurados. E os medicamentos de que necessita o autor, obviamente, são de uso domiciliar.

A RN 487/2022[3] dispõe sobre os princípios para a oferta de contrato acessório de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Contudo a obrigação de o plano cobrir medicação domiciiar é somente para os casos em que o beneficiário tenha realizado contratação específica, o que não ocorreu nesse caso

Ainda sobre o fornecimento de medicação de uso domiciliar, a atual jurisprudência do STJ vai no sentido de excluir o seu fornecimento, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (*Home Care*), nenhum desses casos em discussão, e os incluídos no Rol da ANS para esse fim, na forma dos arts. 10, VI, e 12, I, "c", e II, "g", da lei n° 9.656/98, *verbis*:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento* ***domiciliar****, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;* ***(Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)***
>
> *(...)*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;* ***(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)***
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;* ***(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)***

O STJ[4] já tem o entendimento pacificado de que *"na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim*".

Portanto, a exclusão de cobertura para medicamentos de utilização em ambiente domiciliar está prevista no contrato, no art. 10, VI, da lei dos planos de saúde, bem como no art. 17, parágrafo único, VI, da RN 465/2021 da ANS, com a ressalva dos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, que não é o caso que se cogita, de modo que a operadora não tem a obrigação legal ou contratual de fornecer os medicamentos que o autor necessita para o seu tratamento em ambiente domiciliar.

Consequência disso é a improcedência da ação.

Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação movida JOÃO VICTOR MECCA SOMACAL contra UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo IPCA a contar do ajuizamento e a partir da vigência da lei 14.905/2024, atualização monetária mediante aplicação da taxa SELIC), considerados os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS FREDERICO FINGER, Juiz de Direito**, em 12/12/2024, às 17:36:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10073567870v14** e o código CRC **155a486c**.

---

1. https://portal.novartis.com.br/medicamentos/wp-content/uploads/2021/10/Bula-TRILEPTAL-Comprimido-Revestido-Paciente.pdf ↩
2. https://consultaremedios.com.br/vimpat/bula ↩
3. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0487_31_03_2022.html ↩
4. AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023 ↩